

Trastornos de la Conducta Alimentaria

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué son los TCA?

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son condiciones de salud mental graves caracterizadas por alteraciones persistentes en la relación con la comida, el cuerpo y el peso. Tienen base biológica, psicológica y sociocultural, y no son una elección ni una cuestión de vanidad.

Los TCA tienen una de las tasas de mortalidad más altas entre los trastornos mentales. El diagnóstico y el tratamiento temprano son factores determinantes en el pronóstico.

Características transdiagnósticas:

- Preocupación excesiva por la comida, el peso o la forma corporal
- Alteración de la imagen corporal (percepción distorsionada del propio cuerpo)
- Relación disfuncional con la alimentación (restricción, atracones, purgas o combinaciones)
- Impacto significativo en el funcionamiento físico, social y emocional

02. Principales diagnósticos

Diagnóstico	Características principales
Anorexia nerviosa	Restricción severa de la ingesta. Miedo intenso a ganar peso. Distorsión significativa de la imagen corporal. Puede cursar con conductas purgativas.
Bulimia nerviosa	Episodios de atracones seguidos de conductas compensatorias (vómito autoinducido, laxantes, ejercicio excesivo). Peso generalmente en rango normal.
Trastorno por atracón	Episodios recurrentes de ingesta de grandes cantidades en poco tiempo, con sensación de pérdida de control y malestar marcado, sin conductas compensatorias.
ARFID	Evitación o restricción alimentaria no asociada a imagen corporal. Puede estar vinculada a características sensoriales, miedo a atragantarse o falta de interés en la comida.
Otros TCA especificados	Cuadros que no cumplen todos los criterios de los anteriores pero generan malestar clínico significativo.

03. Señales de alerta

Conductuales:

- Restricción marcada de alimentos o grupos alimentarios
- Rituales en torno a la comida (cortar en pedazos pequeños, comer en orden fijo, pesar los alimentos)
- Evitar comer en presencia de otros
- Ejercicio físico compulsivo o como compensación
- Ir al baño inmediatamente después de comer
- Uso de ropa holgada para ocultar el cuerpo

Físicas:

- Pérdida o fluctuación significativa de peso
- Cansancio, mareos, dificultad de concentración
- Problemas dentales, lesiones en nudillos, inflamación de glándulas (en bulimia)
- Amenorrea u otras alteraciones hormonales

Emocionales y cognitivas:

- Preocupación persistente y perturbadora por la comida, el cuerpo y el peso
- Distorsión de la imagen corporal: percibirse con sobrepeso independientemente del peso real
- Autoestima fuertemente condicionada por el peso o la figura
- Irritabilidad, aislamiento, vergüenza en torno a la comida

04. Factores de riesgo y mantenimiento

Factores predisponentes	Factores de mantenimiento
Predisposición genética y biológica	Ciclos de restricción que perpetúan atracones (en bulimia y BED)
Perfeccionismo, baja autoestima, necesidad de control	Conductas compensatorias que reducen la culpa a corto plazo
Presión sociocultural por la delgadez	Aislamiento social y secretismo
Historia de trauma, abuso o pérdidas	Distorsión cognitiva de la imagen corporal
Comentarios negativos sobre el cuerpo en la infancia	Co-morbididades no tratadas: depresión, ansiedad, trauma

05. Abordaje clínico

El tratamiento de los TCA requiere un enfoque interdisciplinario:

- Evaluación médica y nutricional: estabilización física como primer objetivo en cuadros graves
- Psicoterapia: TCC, terapia basada en DBT, terapia familiar (especialmente en adolescentes)
- Trabajo sobre imagen corporal y autoestima
- Abordaje de comorbididades: ansiedad, depresión, trauma
- Psicoeducación a la persona y su entorno
- Derivación a hospitalización o programa intensivo cuando el riesgo médico lo indica

Nota clínica: La ambivalencia hacia el cambio es parte del cuadro, no resistencia al tratamiento. El vínculo terapéutico y el trabajo motivacional son herramientas clave en las etapas iniciales.